

# Ekspozycja z zapobieganiem reakcji

Stań w obecności wyzwalacza — bez reagowania. Mózg uczy się, że głód mija sam. To **NIE** ekspozycja na pornografię. To ekspozycja na trudne emocje.

**CZAS:** 30–60 min na sesję Po stabilizacji i wsparciu terapeuty

**ŹRÓDŁO:** Marlatt & Donovan (1985, cue exposure); Hallberg i wsp. (2019, RCT)

## JAK UŻYWAĆ

Ekspozycja z zapobieganiem reakcji (ang. *cue exposure with response prevention*) w PPU oznacza **świadome zbliżenie się do wyzwalacza** (samotny wieczór, telefon w rękę, miejsce kojarzone z używaniem) *bez* sięgnięcia po porno. Cel: **nauczyć mózg**, że głód *mija sam* w 20–40 minut, jeśli go nie nakarmić. To *nie* ekspozycja na pornografię — to ekspozycja na **niewygodę abstynencji**. Bez tego głód pozostaje silny latami, bo nigdy nie doświadczasz, że da się go przeczekać.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Donovan (1985) wprowadzili ekspozycję na bodźce (ang. *cue exposure*) w terapii uzależnień jako odpowiednik ERP w terapii OCD. Mechanizm: **habitucja** — powtarzane wystawianie się na bodziec *bez* reakcji uczy mózg, że bodziec nie jest groźny ani konieczny. Bez ekspozycji pacjent *ucieka* przed wyzwalaczami całe życie — co utrzymuje ich moc. Hallberg i wsp. (2019, RCT n=110, terapia CBT-PPU z ekspozycją) wykazali: **65% pacjentów** osiągnęło istotną redukcję objawów po 12 sesjach z ekspozycją; w grupie kontrolnej (CBT bez ekspozycji) — 40%. Praktyczna zasada: ekspozycję rozpoczynamy *po* stabilizacji (4+ tygodni) i pod nadzorem terapeuty. Robiona samodzielnie bez przygotowania może wywoływać silny dyskomfort i nawroty.

## 01 = Trzy elementy ekspozycji

### 1 · WYZWALACZ

Sytuacja, kontekst, emocja, miejsce, które uruchamia głód — *kontrolowanie*, świadomie wystawiamy się na to. Np. wieczór sam w domu, telefon w rękę, łóżko, ulubiona pora.

### 2 · GŁÓD

Naturalna reakcja — pobudzenie, niepokój, „*chcę natychmiast*”. Rośnie 5–15 min, osiąga szczyt, opada. Punkt obserwacji: *nie* oceniam, *nie* walczę — patrzę.

### 3 · ZAPOBIEGANIE REAKCJI

**Nie sięgam** po porno. Nie rozpraszam się też agresywnie — pozostaję z głodem, obserwuję jak mija. Można: oddech, uważność, krótka aktywność fizyczna.

## 02 ● Hierarchia ekspozycji — od najłatwiejszej do najtrudniejszej

Oceń każdy wyzwalacz w skali SUDS (0–100) — subiektywna jednostka dyskomfortu. Zaczynamy od ekspozycji o wartości 30–40 (umiarkowanej). Po opanowaniu — przechodzimy do 50–60. Najtrudniejsze (80–100) — dopiero na końcu.

| WYZWALACZ / SYTUACJA              | SUDS (0–100) | ETAP |
|-----------------------------------|--------------|------|
| np. wieczór sam w domu z laptopem | 40           | 1    |
|                                   |              |      |
|                                   |              |      |
|                                   |              |      |

DATA + GODZINA EKSPOZYCJI

CZAS TRWANIA

— minuty

WYZWALACZ

— konkretna sytuacja, kontekst

SUDS PRZED

— 0–100

SUDS SZCZYT

— najwyższy moment

SUDS PO

— pod koniec ekspozycji

CO ZAUWAŻYŁEM/-AM W TRAKCIE

— ciało, myśli, emocje

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

— co wiem teraz, czego nie wiedziałem/-am

## ✗ Bezpieczeństwo — kiedy NIE stosować



**W pierwszych 4 tyg. abstynencji** — zbyt wcześnie, mózg jeszcze nieadaptowany. Najpierw stabilizacja.



**Bez wsparcia terapeuty** — pierwsze 5 ekspozycji warto omówić, dopiero potem samodzielnie.



**W kryzysie psychicznym** — myśli samobójcze, ciężka depresja, aktywne PTSD wymagają wcześniejszej stabilizacji.



**Zaczynanie od wysokiego SUDS (70+)** — zbyt trudne, kończy się porażką. Zaczynaj od 30–40.

**Ważne rozróżnienie:** ekspozycja w PPU *NIE* oznacza oglądania pornografii. To *nie* jest „ekspozycja w stylu OCD”. To zbliżenie się do **kontekstów**, w których normalnie sięgałeś/-aś — by nauczyć się, że głód mija sam. Oglądanie porno w ramach „ekspozycji” jest **kontraproduktywne** — wzmacnia ścieżkę zamiast ją osłabiać.

**Klucz:** Hallberg i wsp. (2019) w RCT wykazali, że **dodanie ekspozycji** do klasycznej terapii CBT-PPU zwiększa skuteczność o **25 punktów procentowych** w 12-miesięcznej obserwacji. Mechanizm: bez ekspozycji pacjent uczy się unikać wyzwalaczy — co działa krótkoterminowo, ale utrzymuje ich moc. Z ekspozycją uczy się, że *jest w stanie wytrzymać*. To zmienia samoocenę: z „*jestem słaby, muszę uciekać*” na „*mogę być przy głodzie, nie muszę go karmić*”. Średnio 8–15 ekspozycji wystarcza, by głód w danym kontekście spadł z SUDS 70 do SUDS 20–30. To jednorazowa inwestycja czasu w zamian za trwałą zmianę.